

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Hemograma com Contagem de Plaquetas

(Material: Sangue Total)

Série Vermelha

(Método: Impedância / Colorimetria / Fluorescência / Avaliação Microscópica)

Eritrócitos	5,83	10 ⁶ /μL	4,50 a 5,50	10 ⁶ /μL
Hemoglobina	16,3	g/dL	13,0 a 17,0	g/dL
Hematócrito	48,6	%	40,0 a 50,0	%
VCM	83,4	fL	83,0 a 101,0	fL
HCM	27,9	pg	27,0 a 32,0	pg
CHCM	33,5	g/dL	31,0 a 35,0	g/dL
RDW	13,0	%	11,6 a 14,0	%

Série Branca

(Método: Impedância / Colorimetria / Fluorescência / Avaliação Microscópica)

Leucócitos	100	%	7.330	/μL	100	%	4.000 a 10.000	/μL
Neutrófilos	70,1	%	5.138	/μL	40,0 a 80,0	%	1.800 a 7.800	/μL
Eosinófilos	1,8	%	132	/μL	1,0 a 6,0	%	20 a 500	/μL
Basófilos	0,3	%	22	/μL	0,0 a 2,0	%	20 a 100	/μL
Linfócitos	20,0	%	1.466	/μL	20,0 a 40,0	%	1.000 a 3.000	/μL
Monócitos	7,8	%	572	/μL	2,0 a 10,0	%	200 a 1.000	/μL

Diferencial leucocitário liberado por automação, não sendo observados critérios de imaturidade na série neutrofílica para realização de leitura manual da lâmina.

Contagem de Plaquetas

(Método: Impedância)

Contagem de Plaquetas	201.000	/μL	150.000 a 450.000	/μL
VPM	13,6	fL	8,3 a 12,5	fL

Fontes:

Greer, J., 2003. Wintrobe's clinical hematology. 11th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven.

Wong, E., Brugnara, C., Straseski, J., Kellogg, M. and Adeli, K., 2020. Pediatric reference intervals. 8th ed. Academic Press.

Dacie and Lewis, 12ed, 2017.



Assinado eletronicamente por Marli Rambaldi Ribeiro CRF-RJ : 4443 (09/03/2026 16:56 BRT)

da6128d0fc34b1c15028a44fe71b0262c62bc1f12e71349d85214e22c5ff0fab

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.



7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Hemossedimentação (VHS) 1ª hora

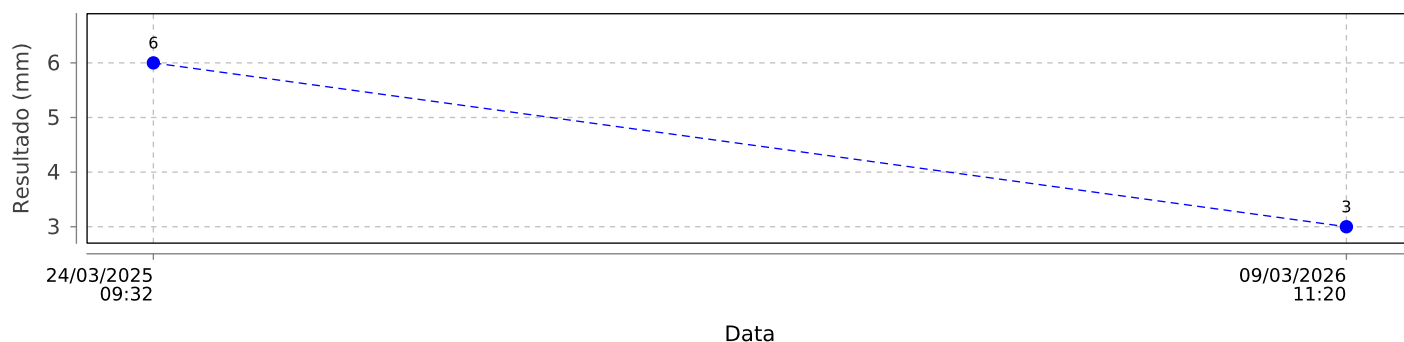
3 mm

Inferior a 15 mm

(Material: Sangue Total)

(Método: Westergren)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por Marli Rambaldi Ribeiro CRF-RJ : 4443 (09/03/2026 19:36 BRT)

ab97d8f7e0105275b6348264f903f8a93fd9d6e2144018a8980172c817d7bb7c

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

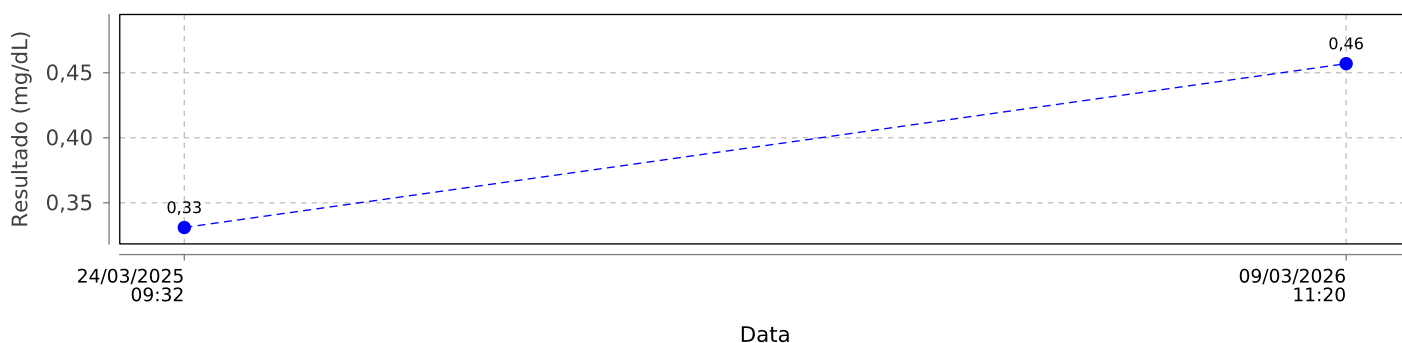
Hora Aproximada: 11:20 BRT

Proteína C Reativa Ultra Sensível**0,46** mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material: Soro)

(Método: Imunoturbidimetria)

Gráfico de Histórico

Obs.: Para obter o resultado em mg/L deve-se multiplicar o valor do resultado por 10.

Tabela de Referência - Proteína C Reativa Ultra Sensível

Interpretação do Risco Cardiovascular:

Baixo Risco: Inferior a 0,10 mg/dL

Médio Risco: 0,10 - 0,20 mg/dL

Alto Risco: Superior a 0,20 mg/dL

Muito alto risco: Superior a 1,00 mg/dL

Nota 1: Na vigência de processo inflamatório agudo observa-se, geralmente, níveis de PCRus > 1,00 mg/dL.

Nota 2: A aplicação deste teste para avaliação do risco cardiovascular requer que sejam excluídas causas inflamatórias, infecciosas ou imunes, uma vez que estas podem interferir na dosagem da PCRus e na interpretação dos valores de referência.

Nota 3: Não se recomenda dosar a PCRus para estratificação de risco em pacientes com doença aterosclerótica manifesta ou subclínica, com alto risco cardiovascular global e em diabéticos.

Referência Bibliográfica:

Kushner I et al. A unifying biologic explanation for "high-sensitivity" C- reactive protein and "low-grade" inflammation. Arthritis Care Res. 2010; 62 (4):442.

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017; Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

Ferro

(Material: Soro)

118 µg/dL

33 a 193 µg/dL

(Método: Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



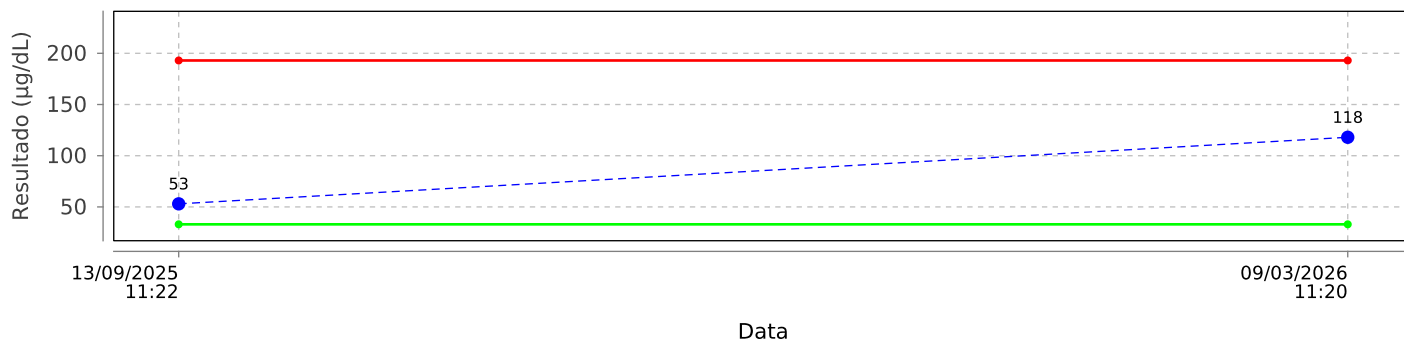
Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT



A concentração sérica do ferro pode sofrer pequenas alterações ao longo do dia (variação circadiana), portanto sua análise deve ser realizada em conjunto com outros marcadores do metabolismo do ferro.

Assinado eletronicamente por Graziela Figueiredo Maia CRBIO-RJ 55798/02 (13/03/2026 15:00 BRT)

31983fee2ae9be5cf17b4e04c6437dd7547c614423a58c9f5cf25e8866ccd1b6

Ferritina

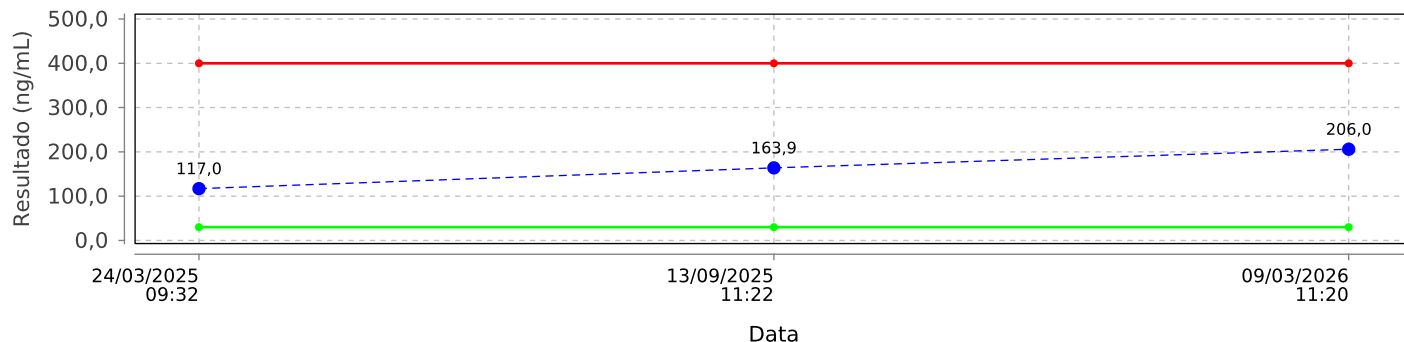
(Material: Soro)

206,0 ng/mL

30,0 a 400,0 ng/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por Julianne Antunes Bastos CRBM-RJ 05785 (12/03/2026 19:21 BRT)

852fd7d864a81fb2ef79c83b961b1cb3d21b2cc1fe7b96087ffc90a3275f6699

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

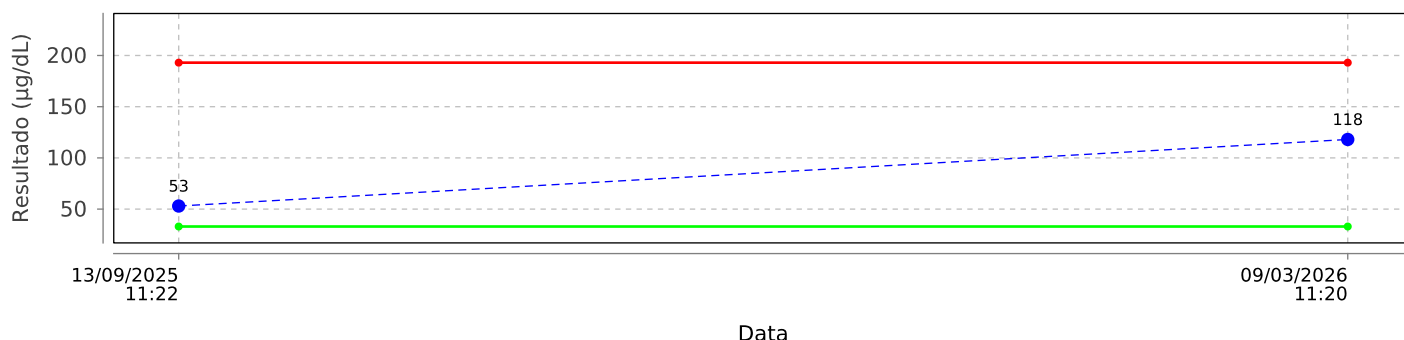
Metabolismo do Ferro

(Material: Soro)

Ferro**118** µg/dL

33 a 193 µg/dL

(Método: Colorimétrico)

Gráfico de Histórico**Capacidade Livre de
Combinação do Ferro****169** µg/dL

de 125 até 345 µg/dL

(Método: Colorimétrico)

**Capacidade Total de Combinação do
Ferro****287** µg/dL

250 a 400 µg/dL

(Método: Cálculo)

Índice de Saturação da Transferrina**41** %

20 a 50 %

(Método: Cálculo)

A concentração sérica do ferro pode sofrer pequenas alterações ao longo do dia (variação circadiana), portanto sua análise deve ser realizada em conjunto com outros marcadores do metabolismo do ferro.

Nota: Os valores de referência do ferro sérico e demais testes envolvidos na avaliação de seu metabolismo são padronizados para amostras colhidas até às 11:00h devido às variações do ciclo circadiano.



Assinado eletronicamente por Graziela Figueiredo Maia CRBIO-RJ 55798/02 (13/03/2026 15:00 BRT)
795c8b9a1602ec7ce730bef04d30b97208c1c56ff926f02a37e92d3a1f25a087

**Vitamina B-12,
Dosagem**

(Material: Soro)

794 pg/mL

245 a 985 pg/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Intervalo de referência estabelecido por método indireto, com base na análise de 6.224 indivíduos avaliados em estudo interno.

Assinado eletronicamente por Julianne Antunes Bastos CRBM-RJ 05785 (12/03/2026 19:22 BRT)
8eacef291bb3fddde982d761ed37366188fa3ea494ea270bae182fea4f0d87c

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Fibrinogênio

(Material: Plasma)

354,00 mg/dL

200 a 400 mg/dL

(Método: Coagulométrico Funcional (Claus))



Assinado eletronicamente por Marli Rambaldi Ribeiro CRF-RJ : 4443 (09/03/2026 16:11 BRT)

23164de2ab40a88437ad0b35af5518a52eb51841c6c840f628f0edce248a2ea8

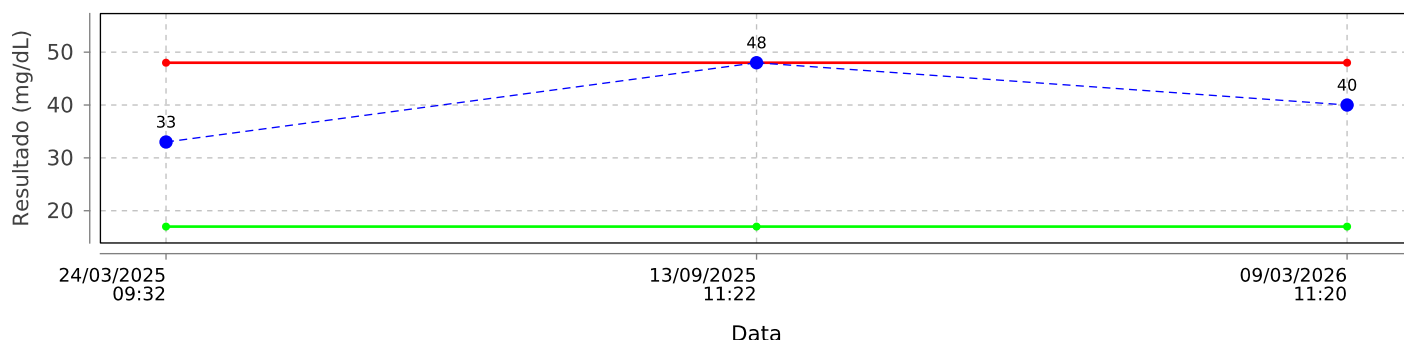
Uréia

(Material: Soro)

40 mg/dL

17 a 48 mg/dL

(Método: Cinético)

Gráfico de Histórico

Assinado eletronicamente por Aline de Moraes Carneiro - CRBM 09656 (13/03/2026 03:51 BRT)

8d51505272af9e85e2fbfe4e3d025262762afe00edbdebd27a84f0c6656c092e

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.



7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Creatinina

(Material: Soro)

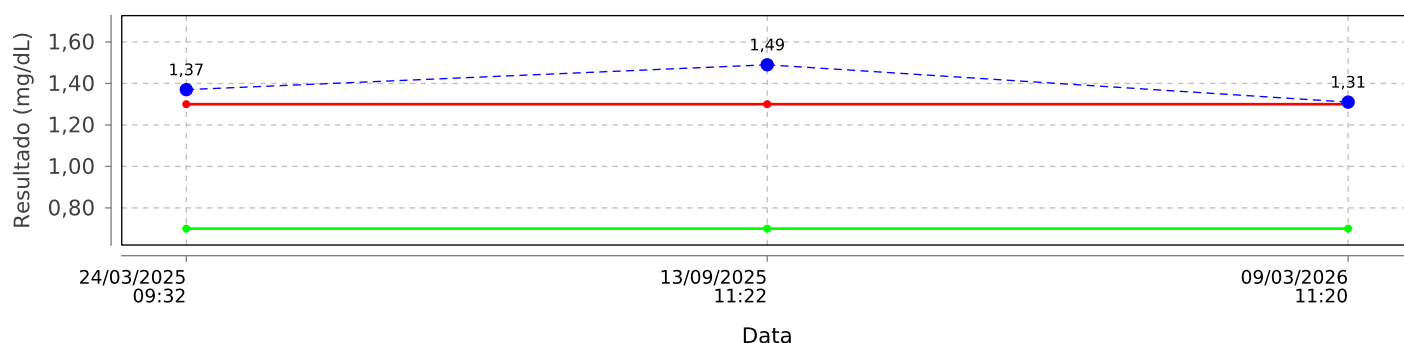
Creatinina

1,31 mg/dL

0,70 a 1,30 mg/dL

(Método: Colorimétrico Cinético (Jaffé))

Gráfico de Histórico



*eGFR

77 mL/min/1,73m²

Superior a 90 mL/min/1,73m²

(Método: Cálculo)

Intervalo de referência da creatinina sérica estabelecido por método indireto, com base na análise de 31.490 indivíduos adultos avaliados em estudo interno.

Nota: Mudança no cálculo da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular a partir de 13/02/2023 (vide referência)

Cálculo da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular (eGFR) pela fórmula CKD-EPI Versão 2021 que retirou do cálculo o critério de afrodescendência.

Esta equação é válida para pacientes acima de 18 anos. Deve-se ter cautela na interpretação da eGFR em gestantes e em pacientes com alterações importantes da massa muscular ou da produção e secreção da creatinina.

Referência:

Delgado, C et al. A Unifying Approach for GFR Estimation: Recommendations of the NKF-ASN Task Force on Reassessing the Inclusion of Race in Diagnosing Kidney Disease. AM J Kidney Dis. 2022 Feb;79(2):268-288.e1.

Assinado eletronicamente por Graziela Figueiredo Maia CRBIO-RJ 55798/02 (13/03/2026 15:02 BRT)

54dcb37f7aa16cceb2482bc618363c05f63e73f83edae79089bfc96797640583

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.



7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Potássio

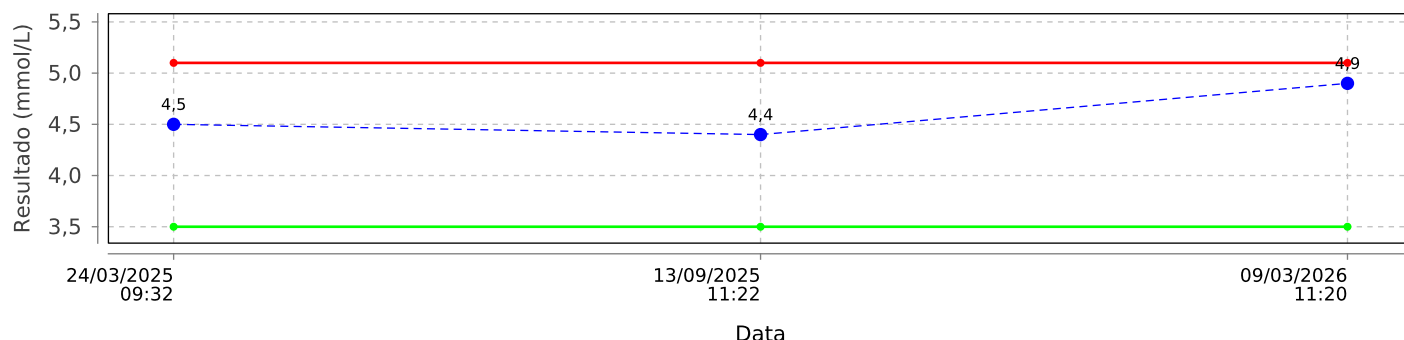
(Material: Soro)

4,9 mmol/L

3,5 a 5,1 mmol/L

(Método: Eletrodo Ion Seletivo)

Gráfico de Histórico



Referência bibliográfica:

Burtis, CA; Ashwood, ER; Bruns, DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. 7th Ed. Saint Louis: Elsevier Saunders, 2015.

Assinado eletronicamente por Graziela Figueiredo Maia CRBIO-RJ 55798/02 (13/03/2026 15:00 BRT)
647c48ca490336a43c5c0646f303588a89ea8e965f1267798d19a0a806c889ad

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.



7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Sódio

145

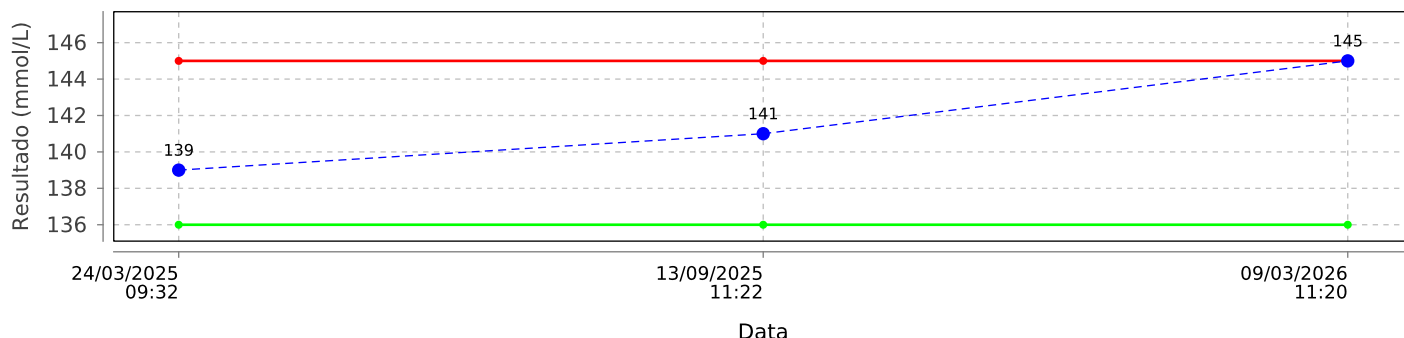
mmol/L

136 a 145 mmol/L

(Material: Soro)

(Método: Eletrodo Ion Seletivo)

Gráfico de Histórico



Assinatura

Assinado eletronicamente por Graziela Figueiredo Maia CRBIO-RJ 55798/02 (13/03/2026 15:01 BRT)
b4080d2bfcc143900594dbaf66099282f36c91899cfbd1bae9336083ca960777

Magnésio

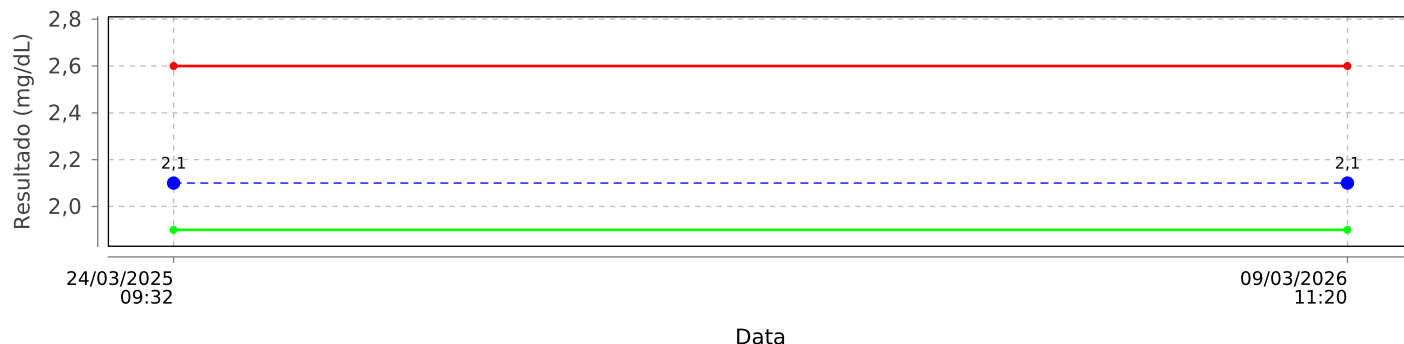
2,1 mg/dL

1,9 a 2,6 mg/dL

(Material: Soro)

(Método: Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Intervalo de Referência estabelecido por método indireto em 38.772 indivíduos atendidos na Dasa, particionados por faixa etária.
Alteração do intervalo de referência a partir de 21/08/2023.

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

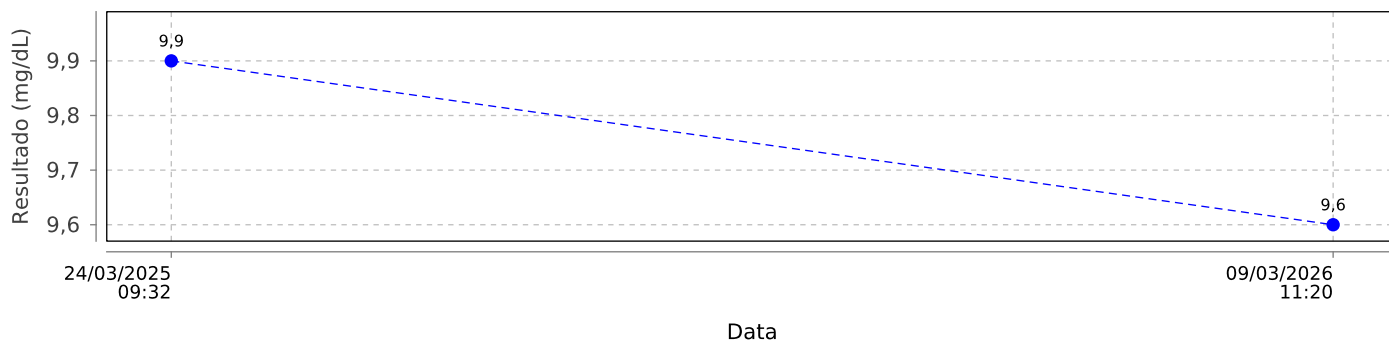
Cálcio

(Material: Soro)

9,6 mg/dL

8,6 - 10,0 mg/dL

(Método: Colorimétrico)

Gráfico de Histórico

Data



Assinado eletronicamente por Graziela Figueiredo Maia CRBIO-RJ 55798/02 (13/03/2026 15:00 BRT)

a0ecb9988cb25e9a86f01595017cc7f64a4123262f5420c220c78809f327bf58

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

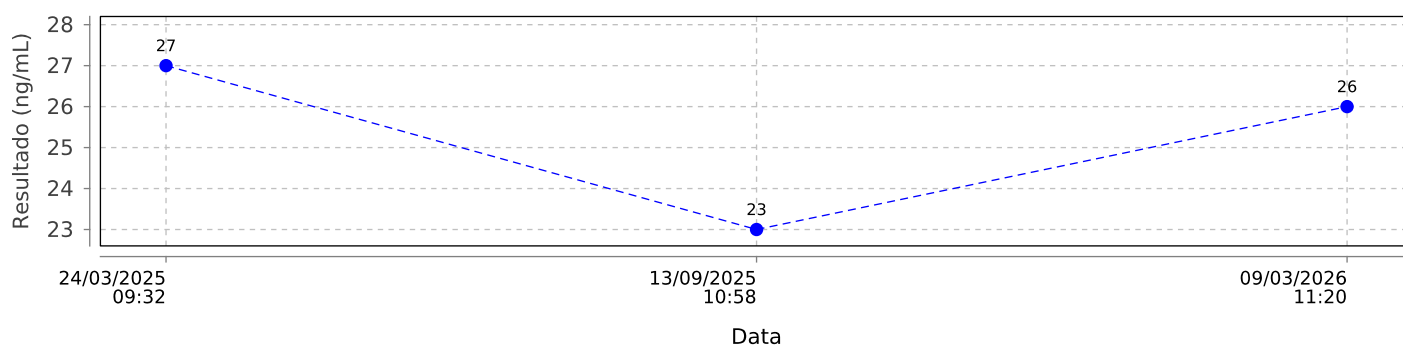
Hora Aproximada: 11:20 BRT

**25-Hidroxivitamina D
(Vitamina D)**

(Material: Soro)

26 ng/mLPopulação saudável abaixo de 60 anos: Superior a 20 ng/mL
População acima de 60 anos e grupos de risco*: 30 a 60 ng/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico**Nota:**

*São considerados grupos de risco para hipovitaminose D: gestantes e lactantes, pacientes com restrição à exposição solar, indivíduos com osteomalácia, raquitismo, osteoporose, hiperparatireoidismo, pacientes acometidos por fraturas ou quedas recorrentes, com doenças autoimunes, doença renal crônica, síndromes de má absorção (como após cirurgia bariátrica e doença inflamatória intestinal) e sob uso de medicamentos que possam interferir com a formação e degradação da vitamina D (como terapia antirretroviral, glicocorticoides e anticonvulsivantes). Valores acima de 100 ng/mL apresentam risco de toxicidade e hipercalcemia.

Referência:

Sociedade Brasileira de Patologia Clínica; Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Posicionamento de Intervalos de Referência da Vitamina D - 25(OH)D [Internet]. 2017.

Assinado eletronicamente por Julianne Antunes Bastos CRBM-RJ 05785 (12/03/2026 19:13 BRT)
acf2090433fd50700716e3b2e19b5fc47ffc71e6a5ecc87ac2afbfa596ab39f2

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.



7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Glicose

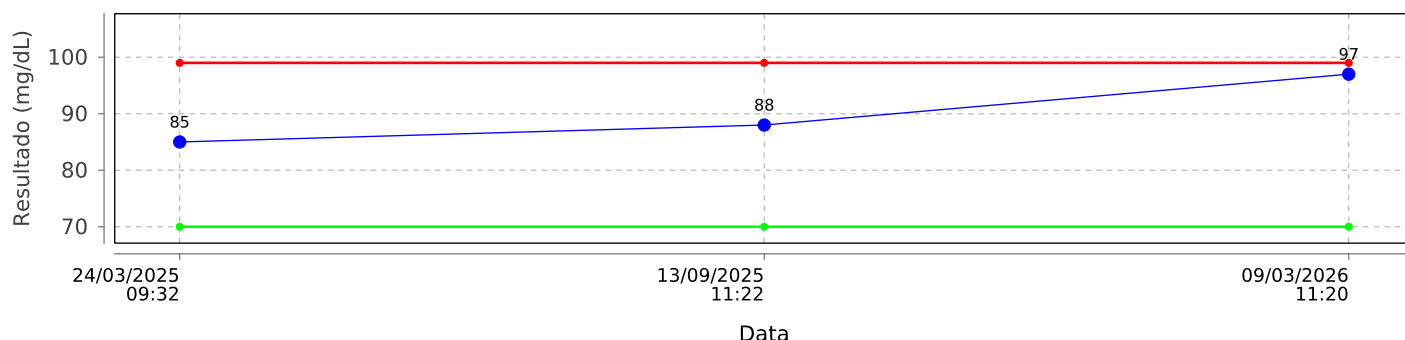
(Material: Soro)

97 mg/dL

70 a 99 mg/dL

(Método: Hexoquinase)

Gráfico de Histórico



Referência Bibliográfica:

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2017.

Valores sugeridos pela Associação Americana de Diabetes.

Assinado eletronicamente por Graziela Figueiredo Maia CRBIO-RJ 55798/02 (13/03/2026 15:01 BRT)
5f2072e62e6b578cb804d58936bcd83ad2df37ae0daed4ea899e7d15743e0f1c

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Hemoglobina Glicada (HbA1c)

(Material: Sangue Total)

Hemoglobina Glicada -
HbA1c

5,2 %

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Imunoturbidimetria)

Gráfico de Histórico

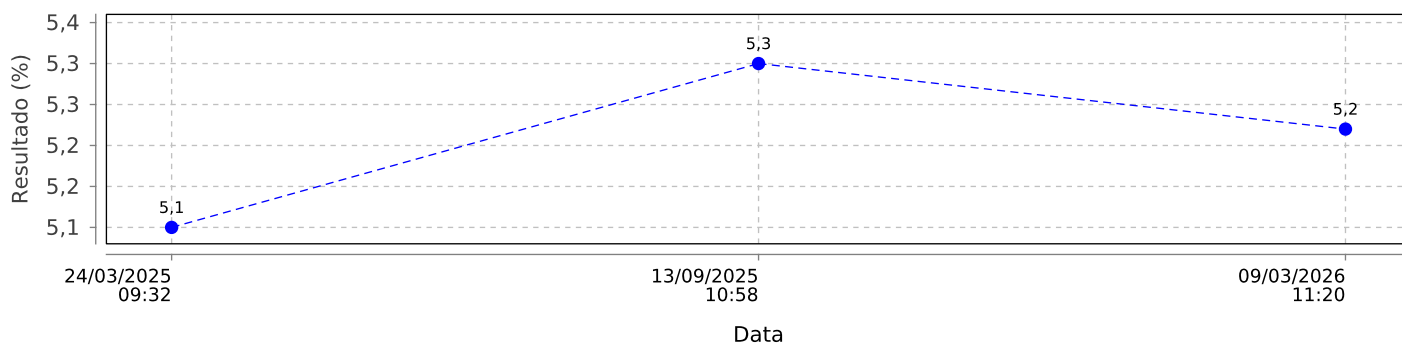


Tabela de Referência - Hemoglobina Glicada - HbA1c

Normal: Inferior a 5,7%
Risco aumentado para Diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4 %
Diabetes Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

**Glicose Média Estimada
(GME)**

103 mg/dL

(Método: Cálculo)

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alterados (glicemia de jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias diferentes.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbA1c inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando o cálculo da glicose média estimada (eAG). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbA1c através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbA1c e a glicose média sanguínea.

American Diabetes Association - Standards of Medical Care in Diabetes 2024. Diabetes Care 2024;47(Supplement_1):S111-S125.

Assinado eletronicamente por Suzana Anastacia de Lima Barreto CRF-RJ 12477 (10/03/2026 01:13 BRT)
f3e34f308fb433b09c6b4acf019d6e8f8ce295679f86c383a6d7ae154a0016bf

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Insulina com Índice HOMA

(Material: Soro)

Insulina**3,5** $\mu\text{UI/mL}$ 2,5 a 13,1 $\mu\text{UI/mL}$

(Método: Eletroquimioluminescência)

Cálculo do Índice de HOMA**HOMA-IR****0,84**

Inferior a 2,70

(Método: Cálculo)

Intervalo de referência da Insulina estabelecido por método indireto em 47.575 indivíduos atendidos nos laboratórios da DASA.

1. O Índice HOMA - Homeostatic Model Assessment - é obtido pela fórmula proposta por Matthews e col. permitindo através da determinação de glicose e insulina de jejum estimar respectivamente a resistência insulínica. Estes índices podem variar de acordo com a população estudada, o índice de massa corporal, apresentação de anticorpos anti-insulina, o uso de alguns medicamentos e condições fisiológicas como puberdade, gestação e senilidade.
2. O cálculo HOMA é realizado diante de glicose sérica entre 70 e 250 mg/dL e insulina sérica entre 2 e 40 $\mu\text{UI/mL}$.
3. O uso HOMA beta não apresenta boa correlação com índices de clamps glicêmicos para sua aplicabilidade na prática clínica. Sua utilização tem sido vinculada ao âmbito de pesquisas clínicas.

Referência Bibliográfica:

Geloneze B, Vasques AC, Stabe CF, Pareja JC, Rosado LE, Queiroz EC et al. HOMA1-IR and HOMA2-IR indexes in identifying insulin resistance and metabolic syndrome: Brazilian Metabolic Syndrome Study (BRAMS). Arq Bras Endocrinol Metab. 2009;53(2):281-7



Assinado eletronicamente por Graziela Figueiredo Maia CRBIO-RJ 55798/02 (13/03/2026 15:03 BRT)

866d1796eb05fb4545ff4702d677e1c7cfc247038f8746574e91a5b2a7c2d150

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Colesterol Total**164** mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material: Soro)

(Método: Enzimático CHOP-POD)

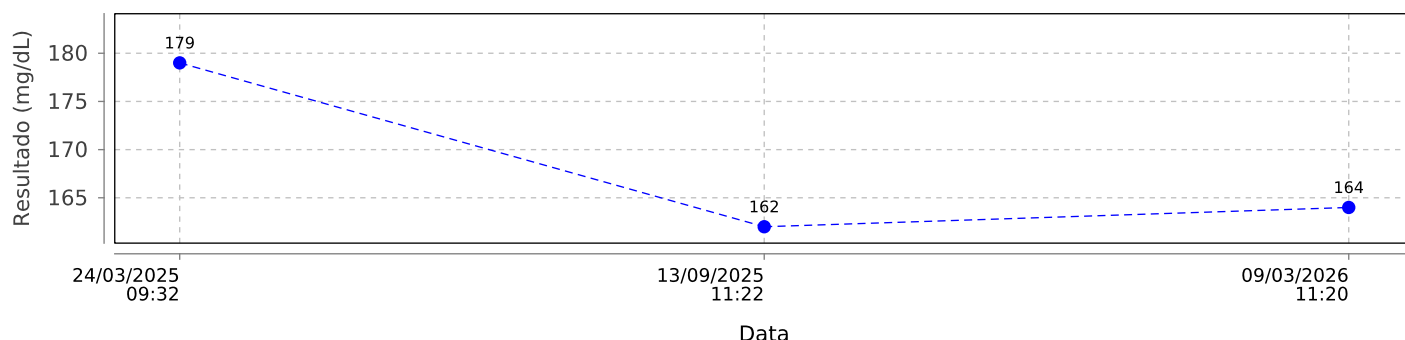
Gráfico de Histórico

Tabela de Referência - Colesterol Total

Com jejum: Inferior a 190 mg/dL
Sem jejum: Inferior a 190 mg/dL**LDL - Colesterol
(calculado)****93** mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Cálculo)

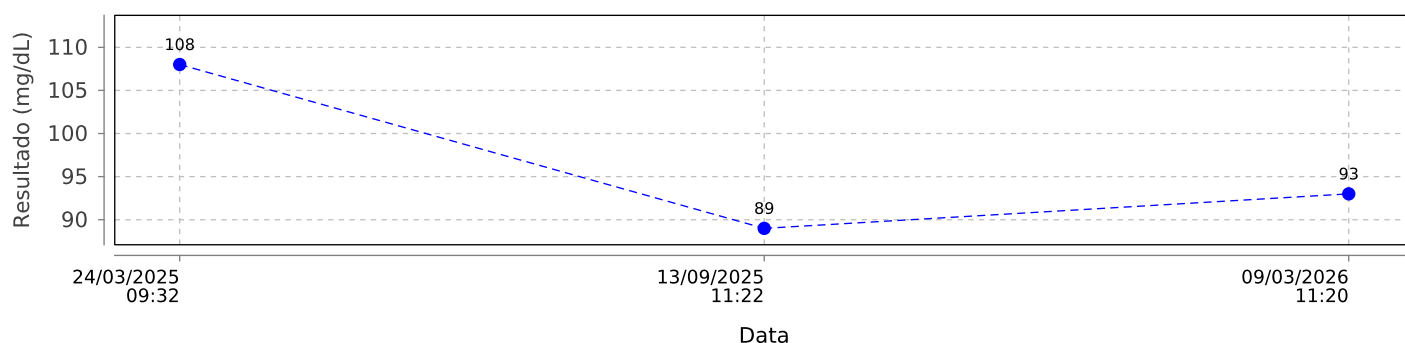
Gráfico de Histórico

Tabela de Referência - LDL - Colesterol (calculado)

Risco cardiovascular estimado e Meta de LDL-C a ser alcançada (com ou sem jejum):

Extremo: Inferior a 40 mg/dL
Muito Alto: Inferior a 50 mg/dL
Alto: Inferior a 70 mg/dL

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Intermediário: Inferior a 100 mg/dL
Baixo: Inferior a 115 mg/dL

Alteração de Intervalo de Referência a partir de 23/02/2026.

A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.

Ref. Bibliográfica: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016.

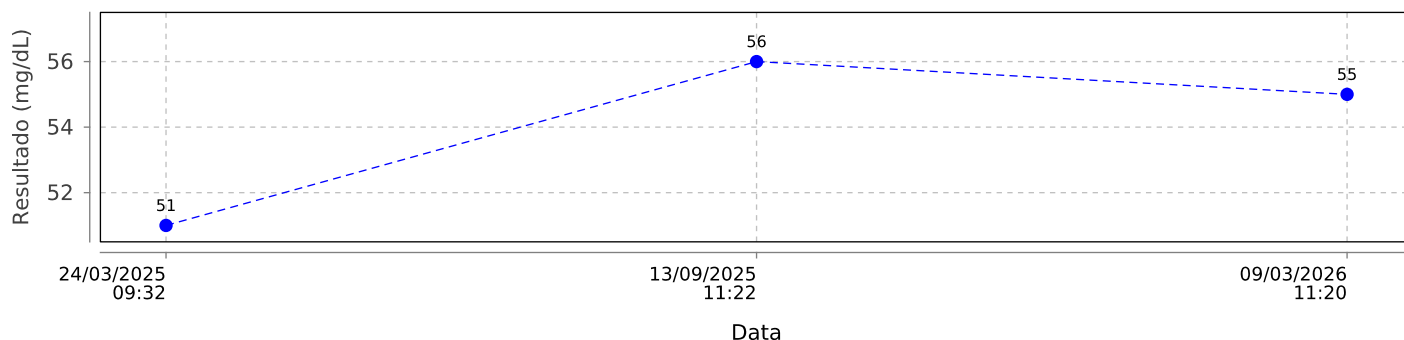
HDL - Colesterol

(Material: Soro)

55 mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: HDL - Colesterol Homogêneo)

Gráfico de Histórico**Tabela de Referência - HDL - Colesterol**Com jejum: Superior a 40 mg/dL
Sem jejum: Superior a 40 mg/dL**VLDL - Colesterol**

(Material: Soro)

17 mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Cálculo)

Gráfico de Histórico

7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

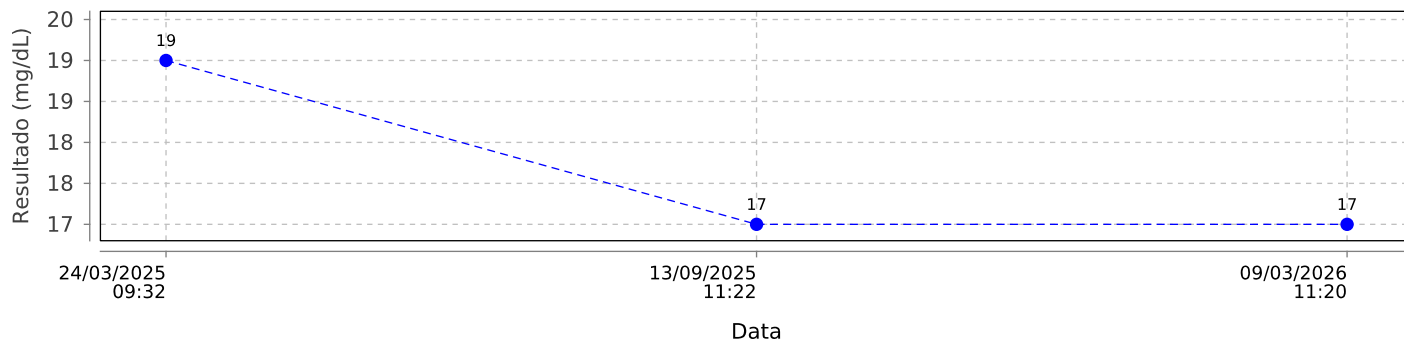


Tabela de Referência - VLDL - Colesterol

Não apresenta intervalo de referência definido.

Triglicérides

(Material: Soro)

77 mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Enzimático CHOP-POD)

Gráfico de Histórico

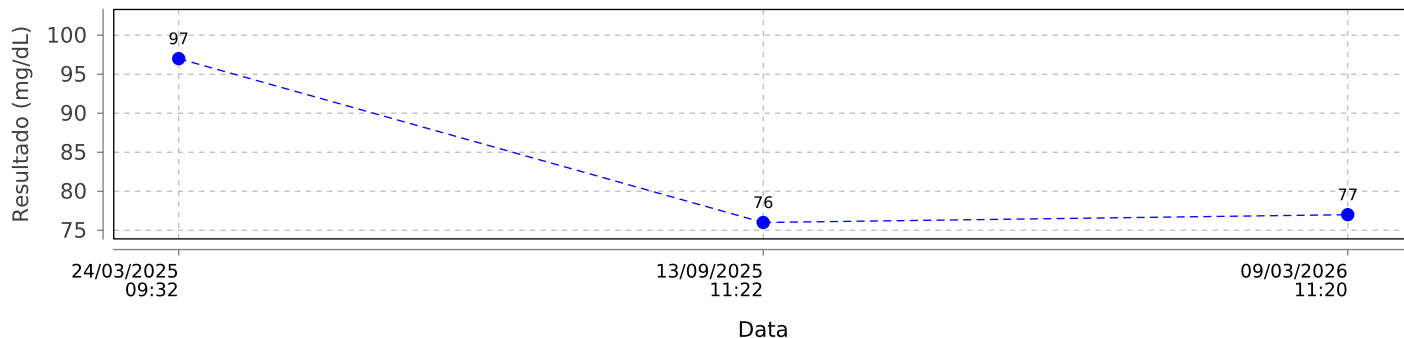


Tabela de Referência - Triglicérides

Com jejum: Inferior a 150 mg/dL
Sem jejum: Inferior a 175 mg/dL

Nota:

Resultados de triglicérides, em 3 coletas diferentes, superiores a 1.000 mg/dL em adultos com jejum de 12 horas e superiores a 880 mg/dL em crianças e adolescentes independentemente do jejum, sugerem Síndrome da Quilomicronemia Familiar.

Referências:

1. Martin SS, Blaha MJ, Elshazly MB, Toth PP, Kwiterovich PO, Blumenthal RS, et al. Comparison of a novel method vs the

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Friedewald equation for estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. JAMA. 2013;310(19):2061-8."

2. Rached et al. Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9): e20250640

3. Izar et al. Posicionamento Brasileiro sobre Síndrome da Quilomicronemia Familiar - 2023. Arq Bras Cardiol. 2023;120(4):e20230203.

Ácido Úrico

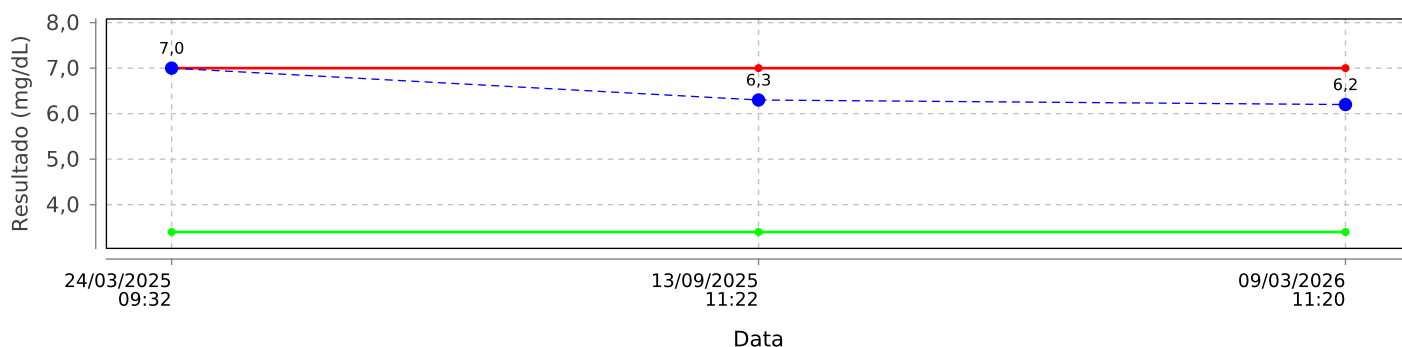
(Material: Soro)

6,2

mg/dL

3,4 a 7,0 mg/dL

(Método: Colorimétrico)

Gráfico de Histórico

Nos pacientes em tratamento de gota, recomenda-se níveis séricos de ácido úrico inferiores a 6 mg/dL.

Referência bibliográfica:

2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. John D. FitzGerald, Nicola Dalbeth, Ted Mikuls, Romina Brignardello-Petersen, Gordon Guyatt, Aryeh M. Abeles, Allan C. Gelber, Leslie R. Harrold, Dinesh Khanna, Charles King <https://doi.org/10.1002/acr.24180>



Assinado eletronicamente por Graziela Figueiredo Maia CRBIO-RJ 55798/02 (13/03/2026 15:01 BRT)

473c21830da1bb368ffbc0448ae6ebabef79cc8c6611ffbf7da4fe2100b07ac

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

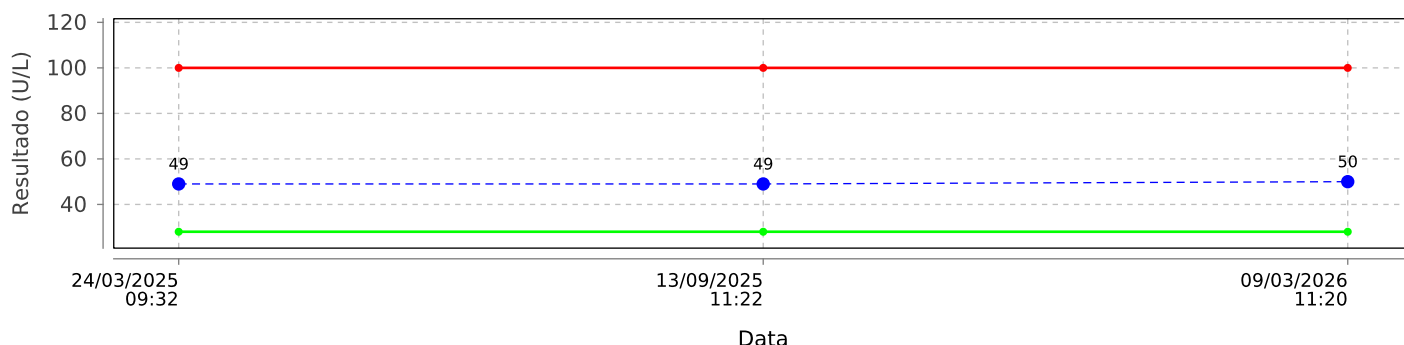
Amilase

(Material: Soro)

50 U/L

28 a 100 U/L

(Método: Enzimático - Colorimétrico)

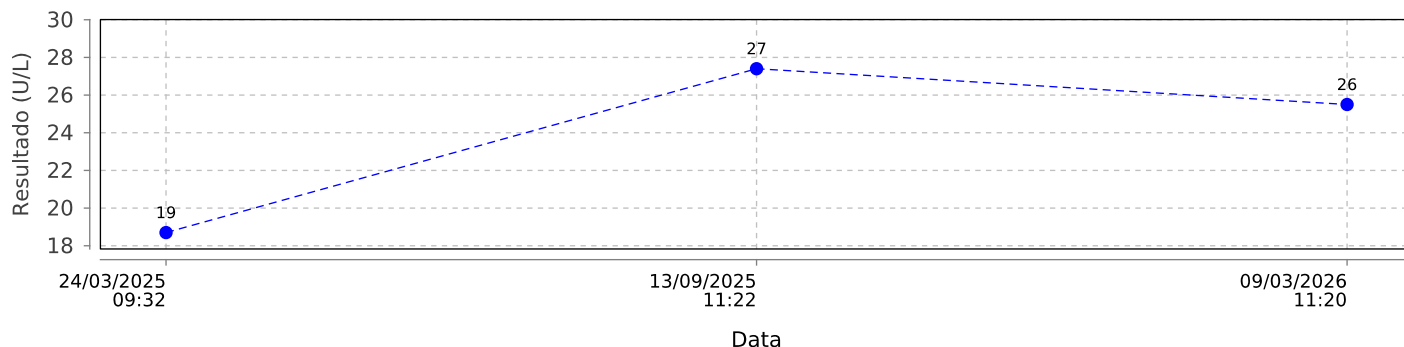
Gráfico de HistóricoReferência Bibliográfica:
BulaAssinado eletronicamente por Graziela Figueiredo Maia CRBIO-RJ 55798/02 (13/03/2026 15:00 BRT)
48e03ae6f91a55f3fe715336bcebfa98636edeb63a9a501fbb5cbc1670a05925**Lipase**

(Material: Soro)

26 U/L

13 a 60 U/L

(Método: Enzimático - Colorimétrico)

Gráfico de HistóricoAssinado eletronicamente por Graziela Figueiredo Maia CRBIO-RJ 55798/02 (13/03/2026 15:01 BRT)
2449f7e2fdd341aa3659ff75e490c4b9ca5d4ccde647b1f95d973f8b86756cd4Data da Geração: 18/03/2026 12:05:53
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 52-0105890-8

Laboratório registrado no CRM/RJ: Sob o número 0111212-0

7700.0189.2977
PG 19 de 34

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.



7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Responsável: Sheila Vasques Leandro Argolo CRF-RJ : 4469

Não HDL - Colesterol

(Material: Soro)

110 mg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Cálculo)

Tabela de Referência - Não HDL - Colesterol

Risco cardiovascular estimado e Meta de NÃO HDL a ser alcançada (com ou sem jejum):

Extremo: Inferior a 70 mg/dL
Muito Alto: Inferior a 80 mg/dL
Alto: Inferior a 100 mg/dL
Intermediário: Inferior a 130 mg/dL
Baixo: Inferior a 145 mg/dL

Assinado eletronicamente por Graziela Figueiredo Maia CRBIO-RJ 55798/02 (13/03/2026 15:01 BRT)

31ab87809aee87fdba002c662c9f27745843c3da8c1a748d2b5e85134ae129a

Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

Hormônio

Tireoestimulante

Ultrasensível (TSH)

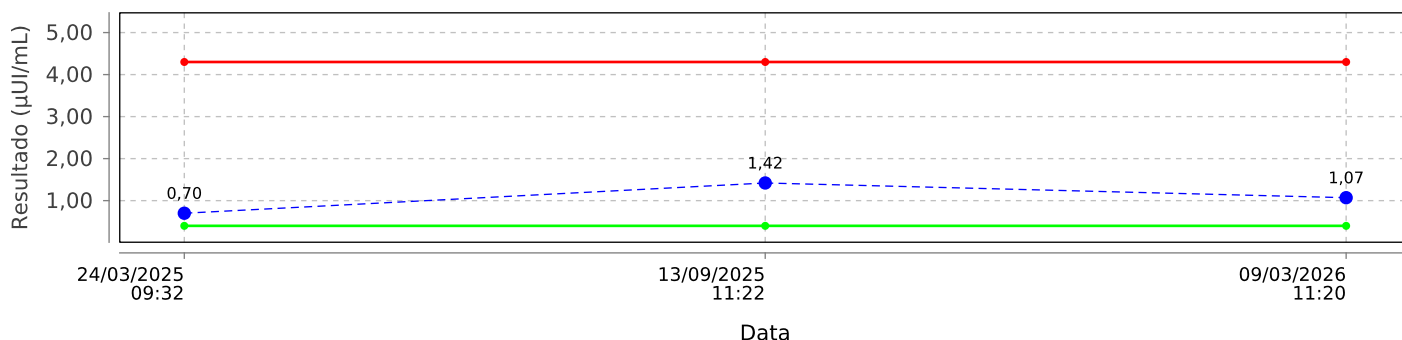
(Material: Soro)

1,07 μ UI/mL

0,40 a 4,30 μ UI/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Alteração de Intervalo de Referência a partir de 20/10/2025.

Referência

Fontes R, Coeli C, Aguiar F, Vaisman M. Reference interval of thyroid stimulating hormone and free thyroxine in a reference population over 60 years old and in very old subjects (over 80 years): comparison to young subjects Thyroid Research 2013;3:12-20.

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

T3 Livre (Triiodotironina Livre)

(Material: Soro)

3,38 pg/mL

2,00 a 4,40 pg/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Assinado eletronicamente por Julianne Antunes Bastos CRBM-RJ 05785 (12/03/2026 19:13 BRT)

a9682eb6856b92ff179f5cfaaa0e7216c2bb741d03d91c4ddc6b9aaa55362d75

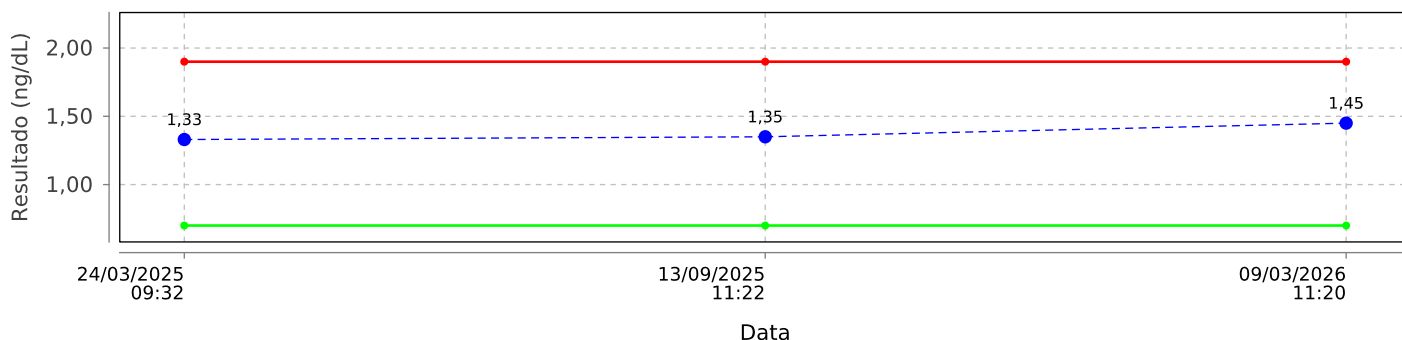
Tiroxina Livre (T4 Livre)

(Material: Soro)

1,45 ng/dL

0,70 a 1,90 ng/dL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico

Alteração de Intervalo de Referência a partir de 16/09/2025.

Referência:

Fontes R, Coeli C, Aguiar F, Vaisman M. Reference interval of thyroid stimulating hormone and free thyroxine in a reference population over 60 years old and in very old subjects (over 80 years): comparison to young subjects Thyroid Research 2013;3:12-20.

Assinado eletronicamente por Julianne Antunes Bastos CRBM-RJ 05785 (12/03/2026 19:21 BRT)

5eef9751bec4ab843b19d820a22734104a0581e2bc398913b346de83bb2151bb

Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

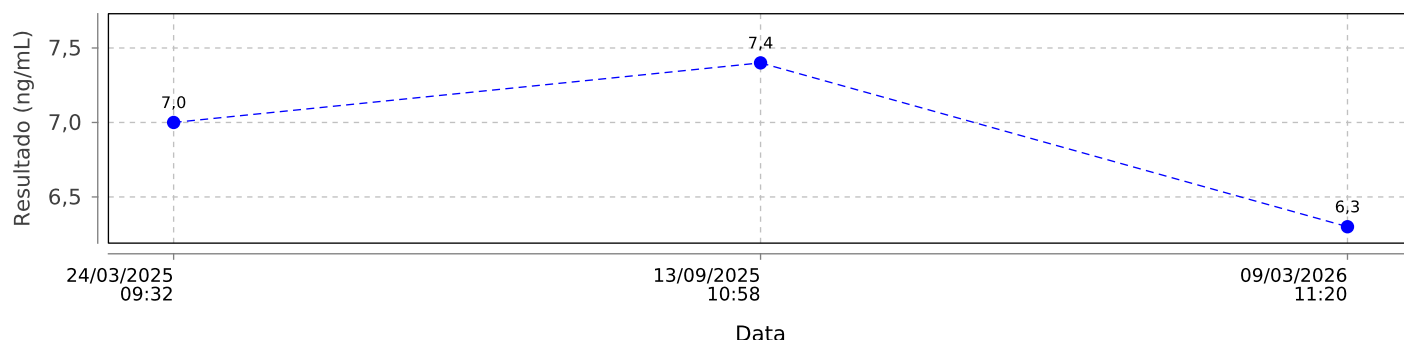
Prolactina

(Material: Soro)

6,3 ng/mL

4,04 a 15,20 ng/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

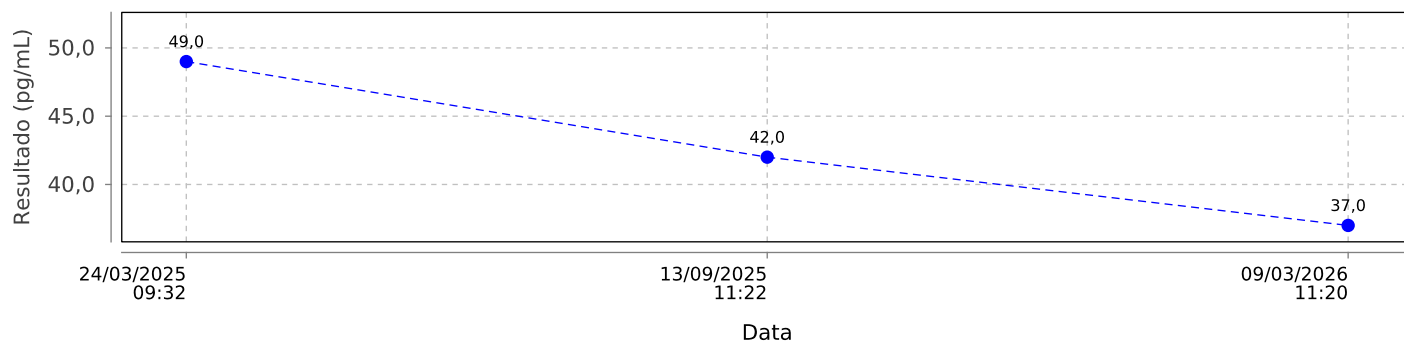
Gráfico de Histórico**Estradiol**

(Material: Soro)

37,0 pg/mL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico**Tabela de Referência - Estradiol**

Feminino < 10 anos: Inferior a 5,0 pg/mL
Feminino 10 a 14 anos: até 68,1
Feminino 14 a 18 anos: 14,6 a 249,0
Feminino 19 anos +:
Fase Folicular: 30,9 a 90,4
Fase Ovulatória: 60,4 a 533,0
Fase Lútea: 60,4 a 232,0
Pós-menopausa: até 138,0

Mulheres Grávidas
1º Trimestre: 154,0 a 3243,0 pg/mL
2º Trimestre: 1561,0 a 21280,0
3º Trimestre: 8525,0 a Superior a 30000,0

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.



7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Masculino < 10 anos : Inferior a 5,0 pg/mL
Masculino 10 a 18 anos: até 36,5
Masculino 19 anos +: 11,3 a 43,2

**FSH - Hormônio
Folículo Estimulante**

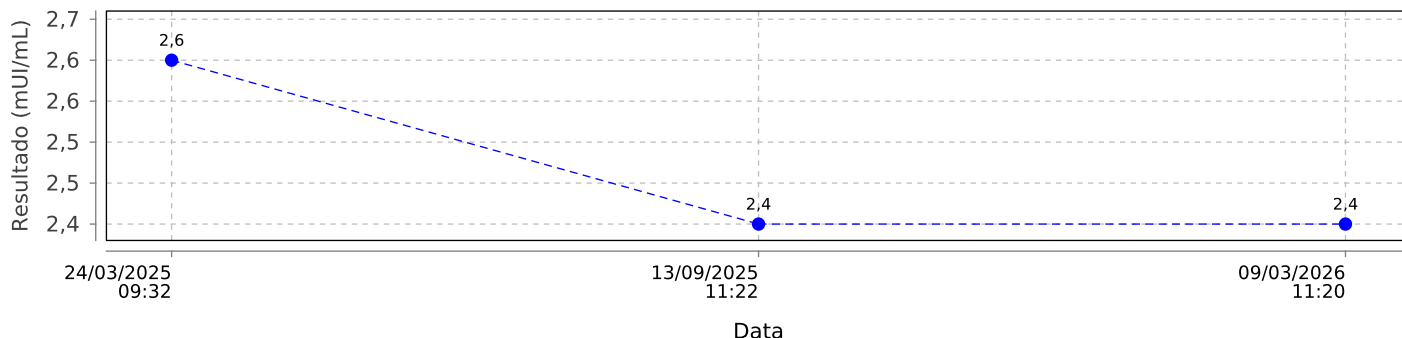
(Material: Soro)

2,4 mUI/mL

Pré Púberes: Até 3,3 mUI/mL
Adultos: 1,5 a 12,4 mUI/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico



**Hormônio Luteinizante
(LH)**

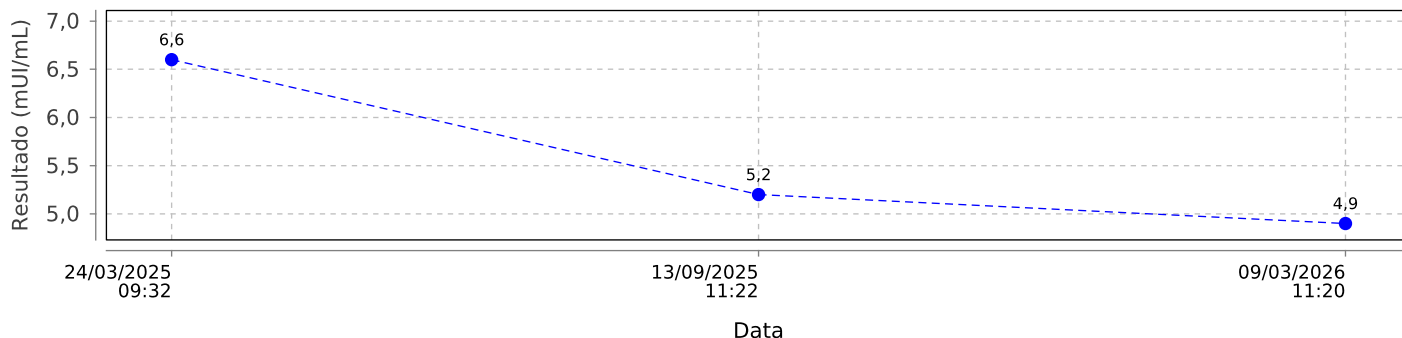
(Material: Soro)

4,9 mUI/mL

Pré Púberes: até 0,3 mUI/mL
Adultos: 1,7 a 8,6 mUI/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por Julianne Antunes Bastos CRBM-RJ 05785 (12/03/2026 19:21 BRT)

f03c7a4719fbc26157e0faecdaa28861b6c212bcbcd4f4dc57ddcc9ed713c238

**SHBG (Globulina
Transportadora de**

49,4 nmol/L

18,3 a 54,1 nmol/L

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Hormônios Sexuais)

(Material: Soro)

(Método: Eletroquimioluminescência)

Assinado eletronicamente por Julianne Antunes Bastos CRBM-RJ 05785 (12/03/2026 19:22 BRT)

381751ae482f52dc6fd3f948f49e86efcbdde3cf883c9f7e6242cca1930e0749

Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

Testosterona Total

(Material: Soro)

875,0 ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico

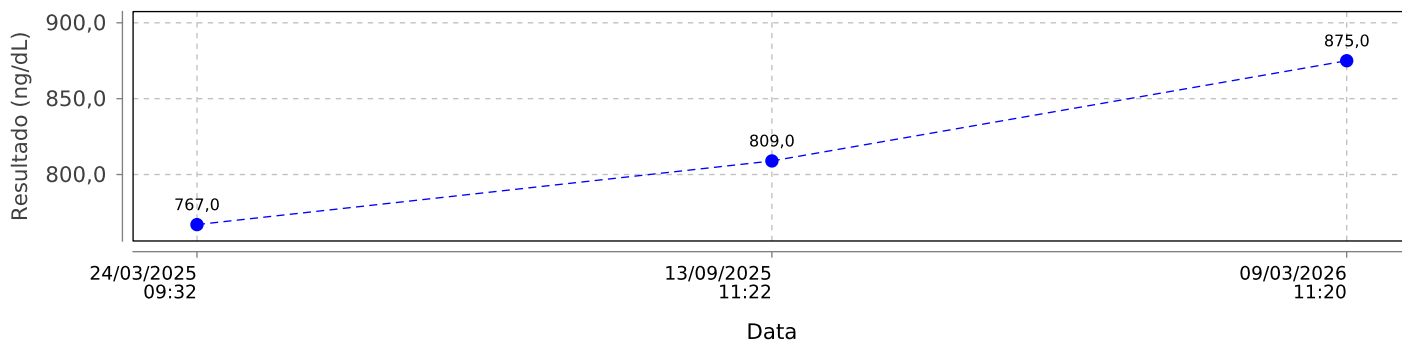


Tabela de Referência - Testosterona Total

Não existem valores de referência pré-definidos para crianças menores de 2 anos.

Feminino

2 a 7 anos: Inferior ou igual a 2,5 ng/dL
7 a 13 anos: 2,5 a 10,4 ng/dL
13 a 18 anos: 2,5 a 23,7 ng/dL
18 a 20 anos: 4,6 a 38,0 ng/dL
20 a 50 anos: 8,4 a 48,1 ng/dL
+50 anos: 2,9 a 40,8 ng/dL

Masculino

2 a 7 anos: Inferior ou igual a 2,5 ng/dL
7 a 13 anos: 2,5 a 432,0 ng/dL
13 a 18 anos: 65,0 a 778,0 ng/dL
18 a 20 anos: 188,0 a 882,0 ng/dL
20 a 50 anos: 249,0 a 836,0 ng/dL
+50 anos: 193,0 a 740,0 ng/dL

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

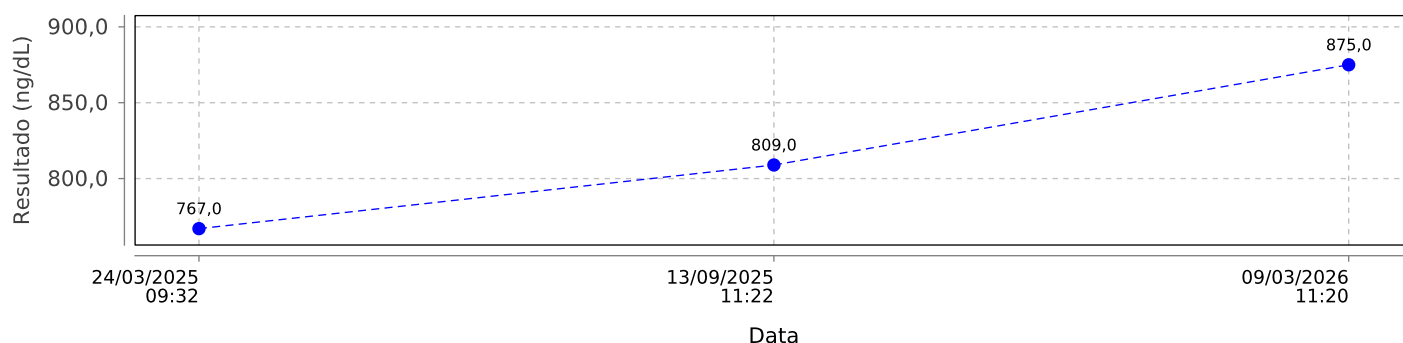
Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas

(Material: Soro)

Testosterona Total**875,0** ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico**Tabela de Referência - Testosterona Total**

Não existem valores de referência pré-definidos para crianças menores de 2 anos.

Feminino

2 a 7 anos: Inferior ou igual a 2,5 ng/dL
7 a 13 anos: 2,5 a 10,4 ng/dL
13 a 18 anos: 2,5 a 23,7 ng/dL
18 a 20 anos: 4,6 a 38,0 ng/dL
20 a 50 anos: 8,4 a 48,1 ng/dL
+50 anos: 2,9 a 40,8 ng/dL

Masculino

2 a 7 anos: Inferior ou igual a 2,5 ng/dL
7 a 13 anos: 2,5 a 432,0 ng/dL
13 a 18 anos: 65,0 a 778,0 ng/dL
18 a 20 anos: 188,0 a 882,0 ng/dL
20 a 50 anos: 249,0 a 836,0 ng/dL
+50 anos: 193,0 a 740,0 ng/dL

SHBG (Globulina Transportadora de Hormônios Sexuais)**49,4** nmol/L

18,3 a 54,1 nmol/L

(Método: Eletroquimioluminescência)

Testosterona Livre Calculada**15,81** ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Livre Calculada**Mulheres**

Pré Púbere: Sem valor de referência definido
Fase Folicular: 0,18 a 1,68 ng/dL
Meio do Ciclo: 0,30 a 2,34 ng/dL
Fase Lútea: 0,17 a 1,87 ng/dL

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.



7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Pós Menopausa: 0,19 a 2,06 ng/dL	
Homens	
Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido	
17 a 40 anos: 3,4 a 24,6 ng/dL	
41 a 60 anos: 2,67 a 18,3 ng/dL	
Acima de 60 anos: 1,86 a 19,0 ng/dL	

Testosterona Biodisponível

370,6 ng/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Método: Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Biodisponível	
Homens	
Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido.	
17 a 40 anos: 82,0 a 626,0	
41 a 60 anos: 58,0 a 436,0	
Acima de 60 anos: 43,0 a 424,0	
Mulheres	
Pré púberes: Sem valor de referência definido.	
Fase folicular: 4,4 a 39,0	
Meio do ciclo: 7,1 a 55,0	
Fase lútea: 4,1 a 44,0	
Pós menopausa: 4,4 a 48,0	

Comentários:

I. O cálculo de testosterona livre fornece uma estimativa confiável da fração livre (não ligada a proteínas), comparável em diversos estudos ao método de diálise de equilíbrio, considerado padrão ouro (1,2).

Testosterona livre calculada = testosterona total - (testosterona ligada à albumina* + testosterona ligada a SHBG).

II. O cálculo de testosterona biodisponível estima a testosterona não ligada à globulina transportadora de hormônios sexuais (SHBG) (3,4).

Testosterona biodisponível calculada = testosterona livre calculada + testosterona ligada à albumina*

* valor padrão de albumina = 4,3 g/dL (1).

Observação: ng/dL x 10(dez) = pg/mL .

III. Em situações de hipoalbuminemia extrema (exs: insuficiência hepática, síndrome nefrótica, queimaduras extensas) ou elevação da SHBG (por exemplo: gestação), estes cálculos tornam-se prejudicados (1,4).

Referências bibliográficas:

- (1) Vermeulen et al. 1999 A Critical Evaluation of Simple Methods for Estimation of Free Testosterone in Serum J Clin Endocrinol Metab 84(10). 3666-3672
- (2) Miller et al. 2004 Measurement of free testosterone in normal women and women with androgen deficiency: Comparison of methods J. Clin. Endocrinol. Metab. 89(2). 525-533.
- (3) Giton et al. 2006 Serum Bioavailable Testosterone: Assayed or Calculated ? Clin. Chem, 52:3 474-481.
- (4) Rosner William et al. 2007 Utility, Limitations and Pitfalls in Measuring Testosterone: An Endocrine Society Position

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.



7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Statement?

J. Clin. Endocrinol.Metabol 92(2) 405-413.

Assinado eletronicamente por Julianne Antunes Bastos CRBM-RJ 05785 (12/03/2026 19:22 BRT)

fcab16047d54cec00a6def23bca823e241640053549747c47b7150c4c6768bea

Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

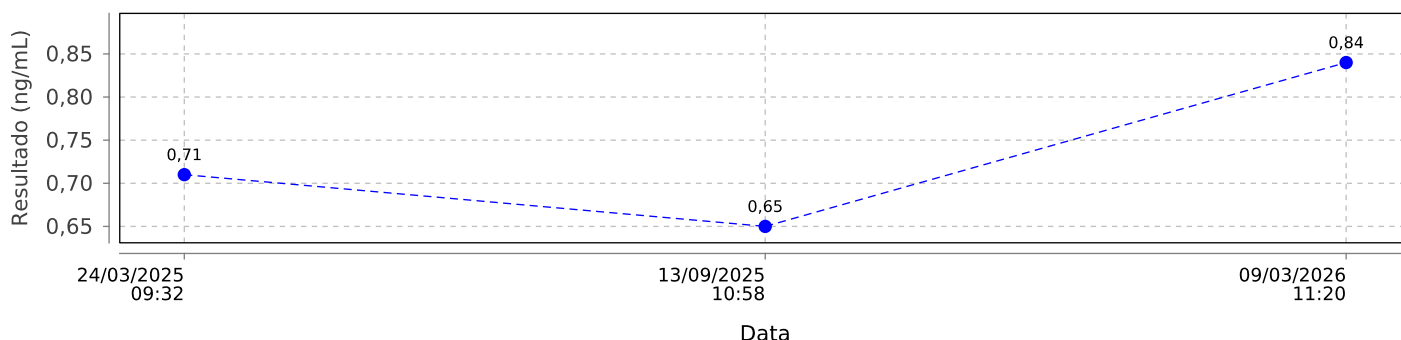
Antígeno Prostático Específico Total**PSA Total**

(Material: Soro)

0,84 ng/mL

Inferior a 4,00 ng/mL

(Método: Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico**Notas:**

Exame executado no equipamento Cobas, do fabricante Roche, pelo método de Eletroquimioluminescência.

Os resultados podem variar entre fabricantes e métodos de ensaio, não sendo comparáveis. Devem ser interpretados dentro do contexto clínico.

Valores elevados de PSA podem ser encontrados em algumas situações como hiperplasia prostática benigna, prostatite, infecção urinária, biópsia prostática, cistoscopia, colonoscopia, toque retal, ejaculação, exercícios físicos (bicicleta), neoplasia de próstata, entre outras.

Um pequeno percentual de indivíduos pode apresentar câncer de próstata mesmo com resultados de PSA Total dentro da faixa de normalidade.

Alguns autores sugerem um ponto de corte mais baixo de 2,5 ou 3,0 ng/mL, e outros recomendam que esse valor seja baseado na faixa etária.

Referências:1. American Cancer Society. Prostate Cancer Early Detection, Diagnosis, and Staging.
<https://www.cancer.org/cancer/types/prostate-cancer/detection-diagnosis-staging/how-diagnosed.html>

2. Partin AW, Criley SR, Subong EM et. al. J Urol. 1996 Apr;155(4):1336-9

Assinado eletronicamente por Julianne Antunes Bastos CRBM-RJ 05785 (12/03/2026 19:21 BRT)

f2204087dcbf7aa5a115b0f1964fcf1e884f80128759b8964d0173fcedcc31f0

Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Cultura de Urina Jato Médio

(Material: Urina - jato médio)

(Método: Cultura quantitativa cinética e/ou convencional com identificação e antibiograma automatizados)

Cultura de Urina

Resultado:

Negativo

Negativo



Assinado eletronicamente por Adriana Lucia Pires Ferreira CRBIO-RJ 21109 (11/03/2026 15:01 BRT)

4300e500c813655d78d24520937e4d229dbe17cecbebeab15e7f00021bf2e735

Exame de Urina de Rotina

(Material: Urina - jato médio)

(Método: Físico Químico Automatizado, Citometria de Fluxo e Microscopia)

Densidade	1.018		1.010 a 1.025
pH	5,0		5,0 a 7,0
Cor	Amarelo Claro		Amarelo Claro ao Amarelo
Aspecto	Ligeiramente Turva		Límpido a Ligeiramente Turva
Proteína	Ausente		Ausente
Glicose	Ausente		Ausente
Corpos Cetônicos, Pesquisa	Ausente		Ausente
Bilirrubina	Ausente		Ausente
Nitrito	Negativo		Negativo
Hemoglobina	Ausente		Ausente
Leucócitos	1	μL	0 a 27 μL
Hemácias	1	μL	Masculino: 0 a 16 μL Feminino: 0 a 27 μL
Cilindros	Ausente		Ausente
Celulas Epiteliais	1	μL	0 a 22 μL
Cristais	Ausente		Ausente

Métodos:

Elementos Anormais - Leitura Automatizada de Tiras Reagentes.

Sedimento - Automatizado por Citometria de Fluxo por imagem e Microscopia Optica.



Assinado eletronicamente por Daniel Buffoni CRBIO-RJ 078636/02 (09/03/2026 16:07 BRT)

7f5e61d29b7723933c6188ff0a674a37e06efaa95187e69023a28f8e6d92dba2

Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Zinco Sanguineo**71,1** µg/dL

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material: Soro)

(Método: Espectrofotometria de Absorção Atômica de Chama)

Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

Tabela de Referência - Zinco Sanguineo

70,0 a 120,0 µg/dL (Carência: abaixo de 30,0 µg/dL)
Até 170,0 µg/dL (Exposição ocupacional)

Assinado eletronicamente por Sheila Vasques Leandro Argolo CRF-RJ : 4469 (16/03/2026 16:25 BRT)

4612f15355be1ecd590cbbca0555c1fbfbfe1afa608d996a4fb2ff184ed86ed9

Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

Vitamina A**0,2** mg/L

(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material: Soro)

(Método: HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Performance))

Tabela de Referência - Vitamina A

1 a 6 anos: 0,2 - 0,4 mg/L
7 a 12 anos: 0,3 - 0,5 mg/L
Maiores de 13 anos e adultos: 0,3 - 0,7 mg/L

Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

Os intervalos de referência foram verificados na população atendida pelo laboratório.



Assinado eletronicamente por Sheila Vasques Leandro Argolo CRF-RJ : 4469 (16/03/2026 15:35 BRT)

ce71192fc32af47aaa4c72eb25124d0ba2558862127c457da665396e3416a54c

Vitamina C**0,3** mg/dL

Valor de Referência:

(Material: Soro)

Homens: 0,2 a 2,1 mg/dL

Mulheres: 0,3 a 2,7 mg/dL

(Método: LDTD - Espectrometria de Massa (LDTD - MS/MS))

Os intervalos de referência foram verificados na população atendida pelo laboratório.

Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.



Assinado eletronicamente por Sheila Vasques Leandro Argolo CRF-RJ : 4469 (13/03/2026 14:14 BRT)

e825d67454d5efdd9640d7134f2a6a6802c79d639554b9e3341af2661f48e032

7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT



Responsável: Dra. Dalva Margareth Valente Gomes - CRM - RJ 52525304

7700.0189.2977 / CIP 7679141507**Guilherme Henrique Oliveira Santos**

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino

**Exame****Resultado****Valor de Referência**

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

Hepatograma

(Material: Soro)

Hepatograma

Proteínas Totais

7,1 g/dL

6,4 a 8,3 g/dL

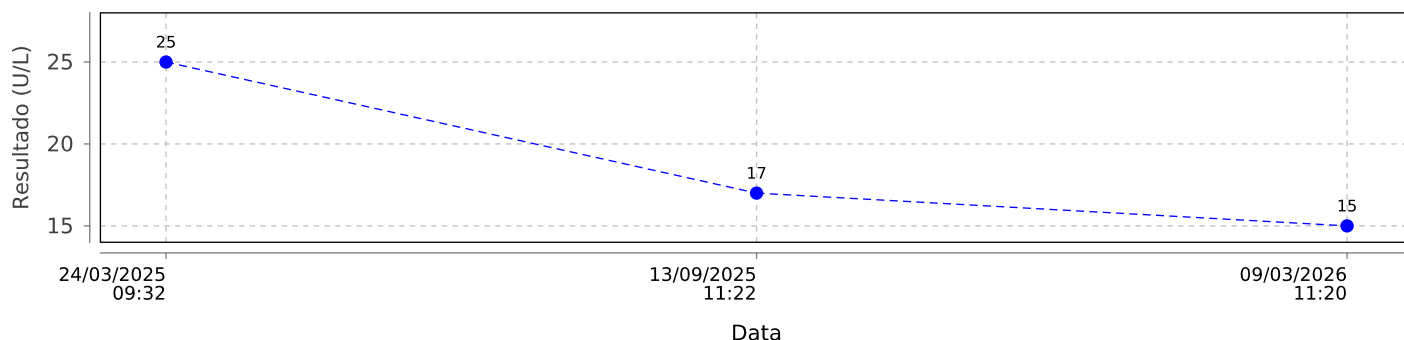
(Método: Colorimétrico)

Transaminase pirúvica - TGP (Alanina amino transferase)

15 U/L

Inferior ou igual a 41 U/L

(Método: Enzimático (IFCC))

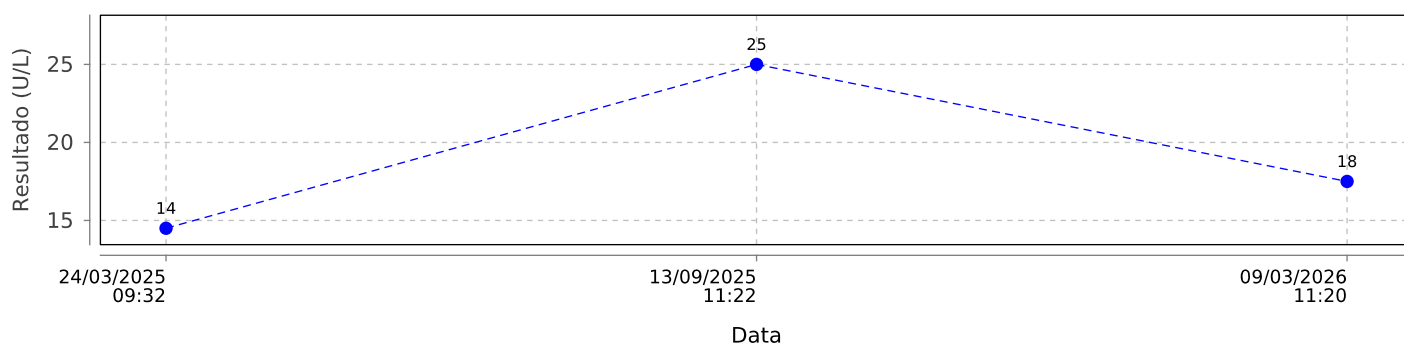
Gráfico de Histórico

Transaminase oxalacética - TGO (Aspartato amino transferase)

18 U/L

Inferior ou igual 40 U/L

(Método: Enzimático (IFCC))

Gráfico de Histórico

Fosfatase Alcalina

117 U/L

40 a 129 U/L

(Método: Enzimático)

Gráfico de Histórico



7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



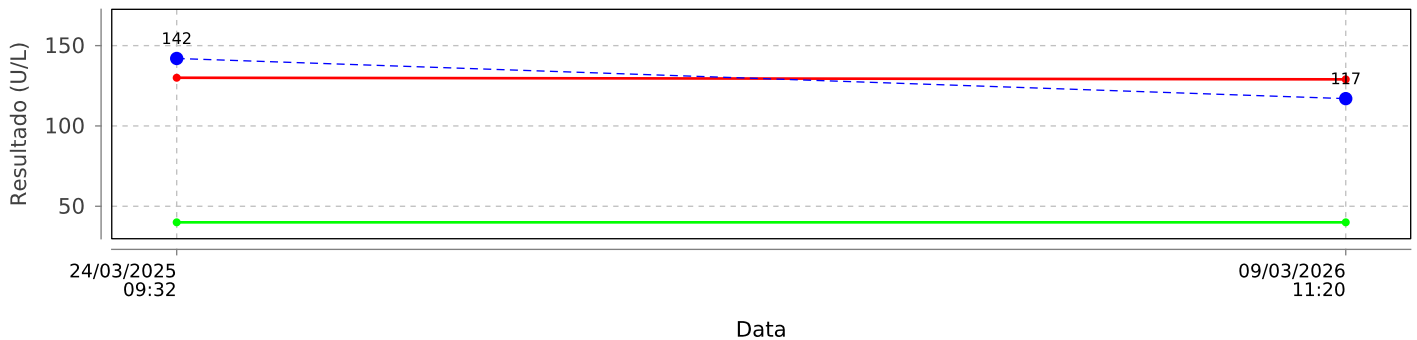
Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT



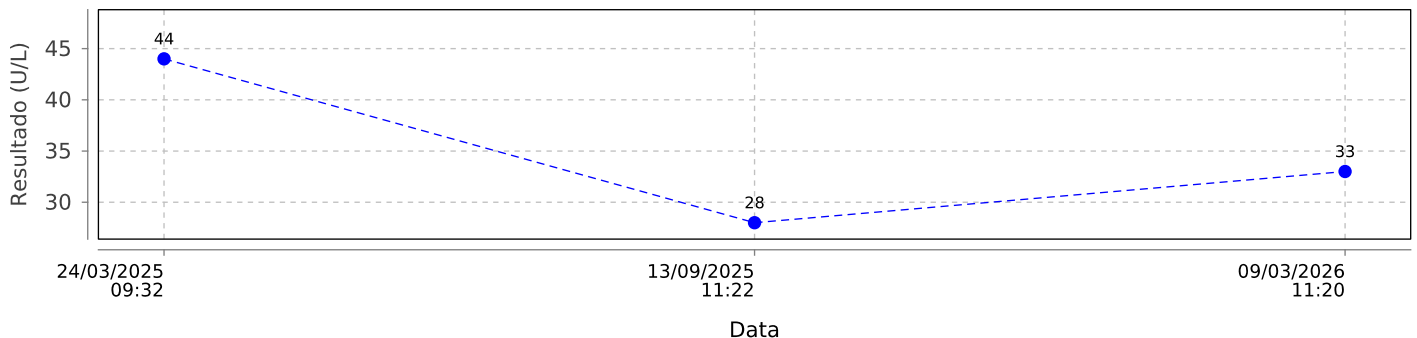
**Gama-Glutamil
Transferase**

33 U/L

Inferior a 60 U/L

(Método: Enzimático - Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



Alteração de Intervalo de Referência a partir de 27/10/2025.

Bilirrubinas Total, Direta e Indireta

Bilirrubina Total **1,06** mg/dL

Inferior a 1,20 mg/dL

(Método: Colorimétrico)

Bilirrubina Direta **0,34** mg/dL

Inferior a 0,30 mg/dL

(Método: Colorimétrico)

Bilirrubina Indireta **0,72** mg/dL

Inferior a 0,90 mg/dL

(Método: Cálculo)

Alteração do Intervalo de Referência a partir de 22/10/2025.

Assinado eletronicamente por Graziela Figueiredo Maia CRBIO-RJ 55798/02 (13/03/2026 15:01 BRT)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.



7700.0189.2977 / CIP 7679141507

Guilherme Henrique Oliveira Santos

Solicitante Nilton Guimaraes Moraes

DN: 01/03/1999 (27 Anos)

Telefone:

SEXO: Masculino



Exame

Resultado

Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 09/03/2026

Hora Aproximada: 11:20 BRT

9042a52136a9fe63d79050c17d1e4b165dffdb85e52d17c312311c937bda7c8a

**Dihidrotestosterona
(DHT)**

(Material: Soro)

423,8 pg/mL

Feminino pré menopausa: Até 596 pg/mL

Feminino pós menopausa: Até 431 pg/mL

Masculino: De 143 a 842 pg/mL

(Método: Ensaio Imunoenzimático)

A metodologia de Imunoensaio possui uma baixa especificidade em algumas situações clínicas. Em caso de discordância clínica-laboratorial, para a maior acurácia da análise, sugerimos a dosagem por Espectrometria de Massas.

Nota: A dosagem sérica de di-hidrotestosterona (DHT) é indicada principalmente na suspeita de deficiência da 5α-redutase. Para diagnóstico e ajuste de dose na terapia de reposição androgênica, recomenda-se a dosagem de testosterona total.

Referência: KHERA, M.; TORRES, L. O.; GROBER, E. D.; MORGENTALER, A.; MINER, M.; JONES, T. H.; et al. Male hypogonadism: recommendations from the Fifth International Consultation on Sexual Medicine (ICSM 2024). Sexual Medicine Reviews, v. 13, p. 548–573, 2025. DOI: 10.1093/sxmrev/qaef036.

BHASIN, Shalender; BRITO, Juan P.; CUNNINGHAM, Glenn R.; HAYES, Frances J.; HODIS, Howard N.; MATSUMOTO, Alvin M.; et al. Testosterone therapy in men with hypogonadism

Assinado eletronicamente por Marinalva De Oliveira Barros CRBio -RJ 60301/02D (14/03/2026 01:37 BRT)

25cd9e8a136489213025bd97eb7667d2d75aa81dd3c194635f166789731c3bad

Locais de execução dos exames:

- DASA - Rua Xavier Pinheiro, 439 Quadra 29 - Pq. Duque de Caxias CNES:7402074 - Duque de Caxias, RJ: 25-Hidroxitamina D (Vitamina D), Amilase, Colesterol Total, Colesterol não HDL, Creatinina, Cultura de Urina Jato Médio, Cálcio, Dihidrotestosterona (DHT), Estradiol, Exame de Urina de Rotina, FSH - Hormônio Folículo Estimulante, Ferritina, Ferro, Fibrinogênio, Glicose, HDL - Colesterol, Hemoglobina Glicada (HbA1c), Hemograma com Contagem de Plaquetas, Hemossedimentação (VHS) 1ª hora, Hepatograma, Hormônio Luteinizante (LH), Hormônio Tireoestimulante Ultrassensível (TSH), Insulina com Índice HOMA, LDL-Colesterol, Lipase, Magnésio, Metabolismo do Ferro, PSA Total, Potássio, Prolactina, Proteína C Reativa Ultra Sensível, SHBG (Globulina Transportadora de Hormônios Sexuais), Sódio, T3 Livre (Triiodotironina Livre), Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas, Testosterona Total, Tiroxina Livre (T4 Livre), Triglicérides, Uréia, VLDL - Colesterol - Cálculo - Martin, Vitamina A, Dosagem, Vitamina B-12, Dosagem, Vitamina C, Zinco Sanguíneo, Ácido Úrico

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.